RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN DEFIBRILATOR DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/2168/2026	No.Revisi 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Alat yang digunakan untuk suatu tindakan terpal dengan cara memberikan aliran energi listrik yang kuat ke jantung pasien melalui elektrode (pedal) yang ditempatkan di dinding dada pasien.
TUJUAN	1. Menghilangkan ancaman kematian karena fibrilasi ventrikel. 2. Mengembalikan irama jantung dan cardiac output yang hilang karena VF / VT non pulse dan mengembalikan oksigenasi dan perfusi jaringan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	PERSIAPAN : A. Perawat harus paham akan : a) Anatomi dan fisiologi kardiovaskuler b) Interpretasi gambaran EKG c) Prinsip BTCLS dan ACLS d) Prinsip keamanan terhadap listrik B. Peralatan : a) DC shock b) Jelly c) Trolley emergency d) Oksigen e) Papan resusitasi kalau perlu C. Pasien : a) Posisi supine. b) Singkirkan semua besi yang menempel langsung ke pasien. c) Ambil gigi palsu bila ada atau yang lain dari pasien.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN DEFIBRILATOR DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.9 / 2168 / 2026	No.Revisi 02	Halaman : 2/2
	CARA KERJA : 1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan serta keringkan. 2. Siapkan pasien dan alat-alat yang diperlukan untuk RJP dan DC shock. 3. Dekatkan defibrilator ke pasien sehingga kabel pedal tidak tertarik. 4. Pasang EKG monitor. 5. Pastikan gambar EKG pasien VT / VF non pulse. 6. Hidupkan defibrilator (posisi asyncronise). 7. Tempatkan pada energi yang diperlukan (pertama kali 200joule). 8. Berikan jelly pada pedal secukupnya (seluruh permukaan9. Tempatkan pedal satu di apex jantung, dan satunya lagi sebelah kanan sternum dibawah klavikula. 9. Charge dan tunggu sampai energi yang diperlukan tercapai. 10. Nyatakan bahwa DC shock telah siap dan aman baik untuk pasien, perawat maupun pemberi bantuan napas kalau ada, dengan mengatakan" CLEAR" 11. Tekan kedua tombol DC shock secara simultan danjangan sampai terangkat.Lihat gambaran EKG post DC shock di monitor berubah irama atau tetap AV / VF. 12. Bila tetap, ulangi lagi dengan energi 300 joule, bila tetap belum berhasil, ulangi dengan 360 joule. Bila masih belum berhasil, lanjutkan dengan RJP Bila setelah DC shock (bisa di lead I, II, III) terjadi perubahan irama, lanjutkan perawatan pasien sesuai irama yang muncul. 13. Matikan defibrilator dan bersihkan pedal, kembalikan alat ke tempat semula		
UNIT TERKAIT	IGD IBS Rawat Inap Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive		